



COLLANA EDITORIALE

POSITION PAPER 01 • 2026

Il farmaco come infrastruttura strategica

Industria farmaceutica, sicurezza sanitaria e autonomia europea

INDUSTRIA • SICUREZZA SANITARIA • AUTONOMIA EUROPEA

POSITION PAPER 01

IL FARMACO COME INFRASTRUTTURA STRATEGICA

Industria farmaceutica, sicurezza sanitaria e autonomia europea

L'Italia come piattaforma industriale, scientifica e logistica per la resilienza sanitaria dell'Unione europea

FONDAZIONE BOSCACCI ETS

AUTORE	Fabio Boscacci
ENTE	Fondazione Boscacci ETS
DATA	Settembre 2026
CODICE	PP/01/2026

Nota editoriale

Questo Position Paper sviluppa e aggiorna l'articolo "Il farmaco è potere: perché l'Italia è diventata un asset strategico per l'Europa", pubblicato su DYNAMES il 18 maggio 2026. La tesi editoriale originaria è stata integrata con dati industriali e fonti istituzionali europee disponibili al 30 settembre 2026. [1]

Executive Summary

La politica farmaceutica europea sta cambiando natura. La disponibilità di medicinali, principi attivi, vaccini e capacità produttive non è più considerata soltanto una questione di mercato o di organizzazione sanitaria: è diventata una componente della sicurezza economica, della preparazione alle crisi e dell'autonomia strategica dell'Unione. Il percorso avviato con la lista europea dei medicinali critici, la Critical Medicines Alliance e il Critical Medicines Act rende esplicita questa trasformazione. [4][5][6][7]

In questo quadro l'Italia dispone di un vantaggio industriale rilevante. Nel 2024 la produzione farmaceutica realizzata nel Paese ha raggiunto circa 56 miliardi di euro, con 54 miliardi destinati all'export, 71.000 addetti diretti e 4 miliardi di investimenti in ricerca, sviluppo e produzione. Nel 2025 la dinamica commerciale si è ulteriormente rafforzata: nei primi dieci mesi l'export farmaceutico è cresciuto del 33,7% su base annua, molto più del totale delle esportazioni nazionali. [2] [3]

Quattro dati che definiscono il posizionamento italiano

56 mld € PRODUZIONE farmaceutica in Italia, 2024	54 mld € EXPORT farmaceutico, 2024	71.000 ADDETTI diretti nel settore	4 mld € INVESTIMENTI R&S e produzione, 2024
---	---	---	--

Fonte: Farmindustria, Indicatori farmaceutici 2025, dati 2024. [2]

Messaggi chiave

- La resilienza sanitaria dipende dalla capacità di produrre, approvvigionare e distribuire medicinali essenziali anche durante shock geopolitici, logistici o industriali.
- L'Italia combina produzione, contract manufacturing, ricerca, università, filiera chimica, logistica e competenze regolatorie: questa rete è un asset europeo, non soltanto nazionale.
- L'autonomia strategica non coincide con l'autarchia. Richiede capacità interna sufficiente, diversificazione internazionale, scorte calibrate e partnership affidabili.
- La sicurezza del farmaco include oggi continuità digitale, cybersecurity, protezione di dati e proprietà intellettuale e resilienza fisica degli impianti.
- Le politiche pubbliche dovrebbero premiare sicurezza di fornitura, qualità, capacità produttiva e innovazione, evitando che il solo prezzo comprima gli investimenti necessari alla resilienza.

Indice

- 01 Perimetro e metodologia
- 02 Dal farmaco alla sicurezza economica
- 03 L'Italia come piattaforma industriale europea
- 04 Dipendenze strategiche e supply chain
- 05 La risposta europea: medicinali critici e capacità produttiva
- 06 Cybersecurity, infrastrutture e intelligence economica
- 07 La dimensione euro-mediterranea
- 08 Opzioni di policy e trade-off
- 09 Indicatori di monitoraggio
- 10 Conclusioni
- 11 Fonti essenziali

1. Perimetro e metodologia

Il documento parte da una tesi editoriale: la capacità farmaceutica è una forma di potenza industriale e un'infrastruttura di sicurezza. [1] Questa tesi viene sottoposta a verifica attraverso quattro livelli di evidenza: dati sull'industria italiana; iniziative europee sulla sicurezza di approvvigionamento; norme sulla resilienza dei settori critici; e politiche europee per competitività e life sciences. [2]-[10]

- I dati economici descrivono scala e dinamica del comparto, non misurano da soli il grado di autonomia strategica.
- La criticità di un medicinale dipende dalla sua rilevanza clinica e dalla disponibilità di alternative, non dal valore economico del prodotto. [7]
- Le raccomandazioni di policy distinguono tra sicurezza dell'offerta, competitività industriale e protezione degli asset: obiettivi con aree di sovrapposizione, ma non equivalenti.

DEFINIZIONE OPERATIVA

In questo Position Paper, "infrastruttura strategica farmaceutica" indica l'insieme di capacità produttive, tecnologie, persone, dati, fornitori, impianti, autorizzazioni, logistica e relazioni internazionali necessarie a garantire nel tempo disponibilità di medicinali e continuità sanitaria.

2. Dal farmaco alla sicurezza economica

L'articolo originario individua un cambio di paradigma: il farmaco smette di essere soltanto sanità e diventa geopolitica. [1] Le iniziative europee successive rafforzano questa lettura. La Commissione ha proposto nel marzo 2025 il Critical Medicines Act per aumentare disponibilità, produzione e sicurezza di approvvigionamento dei medicinali critici. Nel maggio 2026 Consiglio e Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio che punta, tra l'altro, a rafforzare capacità produttiva nell'UE, diversificazione delle catene e strumenti di procurement congiunto. [4][5]

La trasformazione è rilevante perché la vulnerabilità farmaceutica può produrre effetti immediati sul funzionamento degli ospedali, sulla continuità delle cure e sulla fiducia nel sistema sanitario. La Critical Medicines Alliance ha indicato tra i problemi strutturali la concentrazione geografica di principi attivi e materie prime, l'erosione di alcune basi manifatturiere europee e la debole attrattività degli investimenti per prodotti maturi a basso margine. [6]

3. L'Italia come piattaforma industriale europea

Il vantaggio italiano non dipende da un singolo campione nazionale, ma dalla densità dell'ecosistema. Nel 2024 il valore della produzione farmaceutica realizzata in Italia è stato pari a circa 56,1 miliardi di euro; l'export ha rappresentato circa 54 miliardi, mentre l'occupazione diretta ha raggiunto 71.000 persone e gli investimenti in R&S e produzione 4 miliardi. [2]

La dinamica recente suggerisce inoltre che il settore si muove in controtendenza rispetto a parti rilevanti della manifattura. L'ISTAT segnala che tra gennaio e ottobre 2025 le esportazioni farmaceutiche sono aumentate del 33,7% su base annua, a fronte di una crescita del 3,4% dell'export nazionale complessivo; le importazioni farmaceutiche sono aumentate del 44,6%, confermando anche la forte integrazione del comparto nelle catene globali. [3]

PRODUZIONE	SCIENZA	FILIERA	LOGISTICA	REGOLAZIONE
impianti · CMO/CDMO	università · R&S	chimica · packaging	cold chain · hub	qualità · compliance
LA TESI Il valore strategico dell'Italia risiede nella combinazione tra capacità produttiva, specializzazione, qualità regolatoria e integrazione internazionale. L'obiettivo di policy non dovrebbe essere "produrre tutto", ma evitare dipendenze non gestibili nelle funzioni sanitarie essenziali.				

4. Dipendenze strategiche e supply chain

Una filiera farmaceutica è resiliente quando riesce ad assorbire shock senza perdere la continuità di fornitura. La vulnerabilità può derivare da un unico fornitore di API, dalla concentrazione della produzione in una regione, dalla scarsità di capacità di riserva, da vincoli logistici, da dipendenze energetiche o da margini insufficienti a sostenere investimenti in capacità ridondante. [6]

La lista europea dei medicinali critici, aggiornata nel 2025 e oggetto di revisione annuale, serve proprio a concentrare le azioni comuni sui prodotti la cui continuità è prioritaria per i sistemi sanitari. La lista comprende medicinali innovativi e generici e copre molte aree terapeutiche; la qualifica di “critico” è collegata alla gravità della patologia e alla disponibilità di alternative. [7]

Tre forme di dipendenza da distinguere

01 Dipendenza produttiva — assenza o insufficienza di capacità produttiva europea per una sostanza, un intermedio o una forma farmaceutica.

02 Dipendenza concentrata — capacità esistente ma eccessivamente concentrata in pochi siti, fornitori o aree geografiche.

03 Dipendenza economica — produzione tecnicamente possibile in Europa ma non sostenibile nel tempo per condizioni di prezzo, procurement o investimenti.

5. La risposta europea: medicinali critici e capacità produttiva

La risposta europea sta convergendo su una combinazione di politica sanitaria e politica industriale. La Critical Medicines Alliance ha raccomandato investimenti in progetti strategici, strumenti finanziari, procurement più attento alla resilienza, scorte armonizzate e partnership con Paesi terzi. [6] Il Critical Medicines Act traduce questa impostazione in un quadro normativo dedicato, con progetti strategici, procedure facilitate, criteri di procurement e cooperazione tra Stati membri. [4] [5]

Parallelamente, la Strategy for European Life Sciences del luglio 2025 mira a rendere l'Europa il luogo più attrattivo per le scienze della vita entro il 2030, intervenendo su ricerca, accesso al mercato, investimenti e adozione dell'innovazione. [8] Le due linee di policy sono complementari: la resilienza dei medicinali maturi e critici e la competitività dell'innovazione richiedono strumenti differenti, ma condividono infrastrutture, competenze e capacità manifatturiere.

6. Cybersecurity, infrastrutture e intelligence economica

La dimensione strategica non si esaurisce nella capacità fisica di produrre. Gli impianti farmaceutici sono sistemi digitalizzati, con controllo di processo, laboratori, dati di qualità, infrastrutture OT/IT e relazioni di filiera. Un'interruzione cyber può quindi trasformarsi in un'interruzione sanitaria. La direttiva NIS2 include nel settore sanitario i produttori di prodotti farmaceutici di base e, più in generale, rafforza gli obblighi di gestione del rischio cyber per entità essenziali e importanti. [9]

La direttiva sulla resilienza dei soggetti critici (CER) include inoltre, nell'area salute, produttori di prodotti farmaceutici di base e attività di ricerca e sviluppo di medicinali tra i settori che gli Stati membri devono considerare nell'identificazione delle entità critiche. [10] Questo non significa che ogni azienda farmaceutica sia automaticamente "infrastruttura critica"; indica però che la resilienza fisica, operativa e digitale del settore è ormai formalmente inserita nell'architettura europea della sicurezza.

Asset da proteggere

- Know-how produttivo e capacità di scale-up.
- Brevetti, segreti industriali, dati clinici e dataset di ricerca.
- Sistemi di controllo qualità e tracciabilità.
- Continuità energetica, digitale e logistica degli stabilimenti.
- Competenze specialistiche difficili da sostituire in tempi brevi.

7. La dimensione euro-mediterranea

La geografia industriale italiana aggiunge un elemento di valore. Il Paese è connesso ai mercati dell'Europa continentale e, nello stesso tempo, dispone di una proiezione naturale sul Mediterraneo. Questa posizione può sostenere strategie di diversificazione verso partner affidabili nel Mediterraneo allargato, nei Balcani e oltre, senza sostituire la necessità di capacità europee per i nodi più vulnerabili.

Una politica di autonomia strategica aperta richiede quindi due movimenti simultanei: rafforzare in Europa le capacità per medicinali e ingredienti ad alta criticità e costruire partnership internazionali che riducano la dipendenza da singoli fornitori. È la stessa logica indicata dalla Critical Medicines Alliance e dal Critical Medicines Act. [4][6]

8. Opzioni di policy e trade-off

Le seguenti opzioni non sono una graduatoria. Sono leve complementari che richiedono scelte selettive per prodotto, tecnologia e livello di vulnerabilità.

Opzione	Valore strategico	Trade-off / condizioni
Mappare capacità e dipendenze	Identifica molecole, API, siti e fornitori per cui l'UE non dispone di alternative tempestive.	Richiede dati granulari e protezione delle informazioni commercialmente sensibili.
Progetti industriali strategici	Sostiene investimenti in capacità produttive vulnerabili o difficili da finanziare con logiche puramente di mercato.	Va evitata la dispersione degli incentivi su prodotti non realmente critici.
Procurement orientato alla resilienza	Premia pluralità dei fornitori, produzione affidabile, qualità, standard ambientali e continuità.	Può aumentare il costo unitario nel breve periodo; servono criteri misurabili e trasparenti.
Scorte e capacità di riserva	Assorbe shock temporanei e riduce il rischio di interruzione immediata.	Scorte eccessive generano costi, scadenze, sprechi e possibili squilibri tra Stati.
Cyber e business continuity	Riduce il rischio che un incidente digitale blocchi produzione, qualità o distribuzione.	Richiede investimenti continui e integrazione tra OT, IT, qualità e gestione di crisi.
Partnership internazionali diversificate	Riduce la dipendenza da singole aree e amplia le alternative di approvvigionamento.	La diversificazione non elimina rischi geopolitici e richiede verifica di standard e affidabilità.
Attrattività di R&S e manifattura	Mantiene in Europa competenze, investimenti e capacità di innovazione.	Regole e incentivi devono bilanciare sostenibilità della spesa, accesso e competitività industriale.

PRINCIPIO GUIDA

La resilienza non è gratuita. L'obiettivo è rendere esplicito il costo della sicurezza di approvvigionamento e scegliere dove sia giustificato sostenerlo, evitando sia la dipendenza inconsapevole sia la duplicazione indiscriminata delle capacità.

9. Indicatori di monitoraggio

Indicatore	Domanda di policy
Concentrazione geografica di API e intermedi	Quante alternative produttive realmente utilizzabili esistono in caso di shock?
Capacità UE per medicinali critici	La produzione disponibile copre la domanda e dispone di margine di riserva?
Tempo di sostituzione del fornitore	Quanto tempo serve per qualificare un nuovo sito o supplier?
Incidenza criteri non-price nel procurement	Le gare valorizzano sicurezza, qualità e resilienza oltre al prezzo?
Incidenti cyber / downtime produttivo	La continuità digitale è integrata nei piani di sicurezza dell'offerta?
Investimenti e competenze	Il sistema attrae capitale, ricerca e profili specialistici sufficienti?

10. Conclusioni

Il farmaco è una tecnologia sanitaria, un prodotto industriale e, in determinate circostanze, un bene strategico. La distinzione è essenziale: non ogni medicinale richiede la stessa politica industriale, ma la capacità di garantire cure essenziali durante crisi e shock di offerta è una funzione pubblica che non può essere lasciata soltanto alla reazione ex post.

L'Italia parte da una posizione favorevole: base manifatturiera, export, competenze, ricerca e integrazione internazionale. [2][3] Trasformare questa forza in un asset europeo richiede però una politica selettiva e misurabile: identificare le dipendenze realmente critiche, sostenere capacità strategiche, incorporare la resilienza nel procurement, proteggere gli asset digitali e scientifici e mantenere l'Europa attrattiva per ricerca e produzione.

La tesi originaria può quindi essere formulata in termini più precisi: il farmaco diventa “potere” non perché debba essere sottratto al mercato, ma perché la capacità di assicurarla in modo affidabile condiziona salute, stabilità economica e margine d'azione politica. In questo equilibrio, l'Italia può essere uno dei nodi industriali centrali dell'autonomia strategica europea.

11. Fonti essenziali

[1] Fabio Boscacci, “Il farmaco è potere: perché l'Italia è diventata un asset strategico per l'Europa”, DYNAMES, 18 maggio 2026. <https://www.dynames.it/articles/2026.05.18-farmaco-potere.html>

[2] Farindustria, Indicatori farmaceutici 2025: struttura e principali grandezze dell'industria farmaceutica in Italia (dati 2024). https://www.farindustria.it/app/uploads/2022/03/IndicatoriFarmaceutici2025_Def_05082025.pdf

[3] ISTAT, Nota sull'andamento dell'economia italiana - novembre-dicembre 2025, focus sul ruolo della farmaceutica negli scambi commerciali, gennaio 2026. <https://www.istat.it/comunicato-stampa/nota-sullandamento-delleconomia-italiana-novembre-dicembre-2025/>

[4] Commissione europea, Critical Medicines Act, proposta dell'11 marzo 2025 e pagina di attuazione. https://health.ec.europa.eu/medicinal-products/critical-medicines-act_en

[5] Consiglio dell'Unione europea, Critical medicines act: Council and Parliament reach provisional deal, 12 maggio 2026. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/05/12/critical-medicines-act-council-and-parliament-reach-provisional-deal/>

[6] Critical Medicines Alliance, Strategic Report, 28 febbraio 2025. https://health.ec.europa.eu/health-emergency-preparedness-and-response-hera/overview/critical-medicines-alliance_en

[7] European Medicines Agency, Union list of critical medicines, versione aggiornata 2026. <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/post-authorisation/medicine-shortages-availability-issues/availability-medicines-during-crises/union-list-critical-medicines>

[8] Commissione europea, Choose Europe for life sciences - Strategy for European Life Sciences, 2 luglio 2025. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/jobs-and-economy/strategy-european-life-sciences_en

[9] Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2), settori ad alta criticità e obblighi di cybersecurity. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555>

[10] Direttiva (UE) 2022/2557 (CER), resilienza dei soggetti critici. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2557>

Fondazione Boscacci ETS • Position Paper 01 • Settembre 2026